5.5 동의서			
규 정 번 호	5.5	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	5.5 동의서	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	진료부	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 의료법 2. 공정거래위원회 표준약관 동의서		

▣ 목적 (Purpose)

시술 및 진정의 수행, 혈액제제, 고위험의약품, 신체보호대를 사용하는 경우 동의서를 받는 체계를 갖추고 운영한다. 이를 통해, 환자와 보호자의 알 권리와 자기결정권을 보호하고, 의료기관과 의료진의 책임을 명확히 함으로써 적절한 진료를 제공한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 동의서 작성 범위 : 위험 수준이 높거나 흔히 문제가 생기거나 또는 기타 동의를 요구하는 의료 행위에 해당되는 목록을 작성하여 비치
- 고위험 시술 : 의료서비스 중 일부 사용되는 복잡한 기기 및 기구, 치료의 성격(시술의 난이도, 시술기간 등), 환자에게 상해 가능성 또는 특정 약물(화학요법, 조영제 사용 등)의 독성 효과로 인하여 위험성이 높은 시술

▣ 정책 (Policy)

1. 진료동의서에 대한 규정이 있다.
2. 수혈 동의서를 받는다.
3. 혈액제제 사용동의서를 받는다.
4. 고위험의약품 사용동의서를 받는다.

▣ 지침 및 절차

1. 동의서 작성 범위

가. 시술 동의서가 필요한 경우

1) 본원은 동의가 필요한 시술을 시행하지 않는다.

나. 혈액제제 투여가 필요한 경우

다. 고위험의약품 사용이 필요한 경우

1) 인슐린 투여 시
2) 헤파린 투여 시

2. 동의서에 포함하여 환자 또는 보호자에게 제공되어야 하는 정보

가. 환자에게 발생하거나 발생 가능한 증상의 진단명

나. 치료 등의 필요성

다. 치료 등의 방법 및 내용
라. 환자에게 설명하는 의사 및 치료 등에 참여하는 주된 의사의 성명
마. 치료 등에 따라 전형적으로 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용
바. 치료 등 전·후 환자가 준수해야 할 사항 등
사. 설명 수행 의사 및 동의권자 서명

3. 동의권자
가. 환자에게 직접 설명하고 동의를 받는 것을 원칙으로 한다.
나. 환자가 아닌 보호자나 법정대리인이 동의권자가 될 수 있는 경우
1) 환자의 신체적 정신적 장애로 인하여 동의서 내용에 대하여 이해하지 못하는 경우
2) 미성년자로서 동의서 내용에 대하여 이해하지 못하는 경우
3) 동의서 내용을 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 나쁜 영향을 미칠 것이 명백할 경우
4) 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에게 위임한 경우
다. 환자가 아닌 법정대리인에게 동의를 얻는 경우에는 반드시 그 사유를 동의서에 기록한다.

4. 설명 및 동의를 받는 절차
가. 동의서 작성
1) 정확한 환자확인을 한다.
2) 동의서 작성은 환자의 진료를 담당하고 있는 의사가 작성하는 것을 원칙으로 한다.
나. 설명 및 동의를 받는 시기
1) 의료행위 전에 동의서를 받는 것을 원칙으로 한다.(단, 응급상황일 경우 사전 동의절차를 생략할 수 있으며 그 사유를 기록함)
2) 보호자가 원거리에 위치하는 등 보호자가 동의서 작성이 어려운 경우(야간, 보호자 부재, 응급상황)에는 전화로 구두 동의를 먼저 받고 7일 이내 보호자를 방문하도록 하여 서면동의를 받는다. 이를 의무기록에 기록한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 인슐린 사용 동의서
2. 수혈 동의서
3. 헤파린 사용 동의서

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1 인슐린 사용 동의서

고위험 의약품 사용 동의서(인슐린)

등록번호		성 명	
진 단 명			

■ 환자상태 및 특이사항

☐ 고혈압 ☐ 약물부작용 ☐ 당뇨병
☐ 간기능 저하 ☐ 심폐기능 이상 ☐ 혈액응고장애
☐ 특이사항 없음 ☐ 기타( ) ☐ 감기

■ 내용설명

1. 인슐린 사용 등의 필요성
췌장등의 문제로 인슐린 분비 기능 자체가 떨어지는 제 1형당뇨병과 인슐린의 분비가 되더라도 제 기능을 하지 못하는 제 2형 당뇨병의 경우 인슐린이 체내에 생성되지 않거나 인슐린의 기능이 원활 하지 않을 때 인슐린 투여가 필요합니다.

2. 인슐린 사용 등의 방법 및 내용
인슐린은 펜 형태의 주사제를 사용하거나 직접 의약품 제제에서 주사기에 뽑아 피하지방이 많고 관절과 거리가 먼 부위에 주사를 합니다. 대표적인 부분으로 둔부, 상완부 바깥쪽, 대퇴부 바깥쪽, 복부에 맞으며 복부는 인슐린의 흡수가 빠르고 피하지방층이 많고 운동에 영향이 없어 인슐린 주사부위로 많이 사용합니다.

3. 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용
투여 후 과민반응으로 소화불량, 구토, 가려움, 발적, 혈압강하, 두드러기가 발생할 수 있으며 주사부위의 발적등의 부작용이 발생할 수 있습니다. 매운 드문 확률로 호흡곤란 등의 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다.

4. 발생하거나 발생 가능한 증상의 진단명
인슐린 투여후 발생 가능한 증상 및 진단으로는 어지러움, 식은 땀을 동반하는 저혈당이 발생 할 수 있습니다

6. 치료 등 전 후 환자가 준수하여야 할 사항
주사제를 투여할 부위는 늘 청결하게 관리가 필요합니다. 인슐린 주사 투여 후 저혈당을 예방하기 위하여 어지러움, 식은땀, 기력저하 등이 발생하면 즉시 당분을 섭취 할수 있도록 해야합니다. 또한 식사 시간과 투여 시간을 맞추어 혈당 변동을 최소화 하여야 합니다.

■ 확인서약

본인은 고위험 의약품 사용에 대한 상기의 설명 및 고위험 약물 사용으로 발생할 수 있는 합병증에 대하여 충분한 설명을 들었으며 이에 동의하여 약물사용을 확인합니다.

년 월 일

• 대리인 서명하는 경우 사유(해당사항에 V 하세요.)

☐ 환자가 의사결정을 하기 힘든 신체적 정신적 장애로 약정 내용에 대하여 이해하지 못하는 경우
☐ 미성년자로서 약정 내용에 대하여 이해하지 못하는 경우
☐ 동의서에 포함된 내용을 설명했을 시 환자의 심신에 중대한 영향을 미칠 것이 우려되는 경우
☐ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에게 위임하는 경우

동의자(법정대리인) : (인)
환자와의 관계 :
설명의 : (인)

부록2. 수혈 동의서

수 혈 동 의 서

등록번호		환자명		성별/나이	/
진료과		병실		주치의	

아래 설명을 듣고 이해하신후 수혈동의서에 서명하여 주시기 바랍니다
설명이 불충분하거나 이해가 되지 않는 점이 있으시면 설명의사에게 질문하여 주시기 바랍니다

1. 환자분은 다음과 같은 이유로 수혈이 필요합니다
   - ☐ 빈혈의 교정
   - ☐ 혈소판 및 응고인자의 보충
   - ☐ 출혈로 인한 저혈압의 교정
   - ☐ 기타

2. 환자분에게 수혈되는 혈액제제 종류입니다
   - 가. 적혈구 제제 : 320ml ☐ 400ml ☐
   - 나. 혈소판 제제 : 320ml ☐ 400ml ☐
   - 다. 기타 :

3. 수혈전 안전성을 확인한 혈액이지만 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다

가. 37℃ 이상의 열
나. 오한, 발적, 부종, 두드러기 등의 과민반응
다. 호흡곤란, 흉통, 심계항진등의 순환계 변화
라. 혈뇨, 핍뇨 등의 용혈 반응
마. 기타: 저체온, 출혈성 경향 등

본인(보호자)은 수혈후 발생될 수 있는 수혈 부작용에 대하여 충분히 설명 듣고 이해하였으며,
본인에게 수혈이 꼭 필요하다고 판단되는 경우에는 주치의 판단에 따라 수혈을 받고자 합니다

년 월 일

환자명: (서명)

대리인 또는 보호자(환자의): (서명)

주치의/설명의사: (서명)

4. 대리인이 서명하게 된 이유
   - ☐ 환자의 신체적, 정신적 장애로 인하여 약정내용에 대하여 이해하지 못함
   - ☐ 설명하는 것이 환자의 심신에 중대한 나쁜 영향을 미칠것이 명박함
   - ☐ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에게 위임함
   - ☐ 기타:

네이처 요양병원

부록3. 헤파린 사용 동의서

고위험 의약품 사용 동의서(헤파린 혈전예방용)

등록번호		성 명	
진 단 명			

■ 환자상태 및 특이사항

☐ 고혈압 ☐ 약물부작용( ) ☐ 당뇨병
☐ 간기능 저하 ☐ 심폐기능 이상 ☐ 혈액응고장애
☐ 특이사항 없음 ☐ 기타( )

■ 내용설명

1. 헤파린 사용 등의 필요성
혈전증 치료 및 예방, 심부정맥혈전증(DVT), 폐색전증(PE), 혈관 내 혈전 예방, 혈액순환 유지, 기타 혈전 관련 질환이 발생하거나 악화될 경우 혈류 장애로 인해 심각한 합병증이 발생할 수 있으므로 적절한 항응고 치료가 필요 합니다.

2. 헤파린 사용 등의 방법 및 내용
헤파린은 정맥주사 또는 피하주사로 시행하며 혈액검사(aPTT 등)를 확인하며 용량을 조절할 수 있습니다. 필요 시 지속 정맥주입을 시행하며 환자의 상태 및 혈전 위험도에 따라 투여 기간을 결정 합니다.

3. 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용
헤파린 사용 시 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있으며, 대부분 경미하거나 드물게 발생 합니다.
- 주사 부위 통증 또는 멍
- 경미한 출혈
- 잇몸 출혈
- 코피

4. 발생하거나 발생 가능한 증상의 진단명
헤파린 투여 후 발생 가능한 증상 및 진단으로는 출혈, 위장관 출혈, 헤파린 유발 혈소판 감소증, 약물 과민반응 등이 발생 할 수 있습니다.

6. 치료 등 전 후 환자가 준수하여야 할 사항
환자분은 헤파린 투여 후 출혈 증상(코피, 잇몸 출혈, 혈뇨, 혈변 등)이 발생 하면 즉시 의료진에게 알려야 하며 멍이 쉽게 생기거나 심한 두통이 있을 경우 즉시 의료진에게 알려야 합니다. 또한 항응고제 복용 사실을 타 의료기관 진료시 다른 의료진에게 사전에 알려주시기 바랍니다.

■ 확인서약

본인은 고위험 의약품 사용에 대한 상기의 설명 및 고위험 약물 사용으로 발생할 수 있는 합병증에 대하여 충분한 설명을 들었으며 이에 동의하여 약물사용을 확인합니다.

년 월 일

• 대리인 서명하는 경우 사유(해당사항에 V 하세요.)
☐ 환자가 의사결정을 하기 힘든 신체적 정신적 장애로 약정 내용에 대하여 이해하지 못하는 경우
☐ 미성년자로서 약정 내용에 대하여 이해하지 못하는 경우
☐ 동의서에 포함된 내용을 설명했을 시 환자의 심신에 중대한 영향을 미칠 것이 우려되는 경우
☐ 환자 본인이 승낙에 관한 권한을 특정인에게 위임하는 경우

동의자(법정대리인) : (인)
환자와의 관계 :
설명의 : (인)